만성췌장염 외래 추적: 통증·영양·혈당·암 위험 신호

통증만 보지 말고 외분비기능부전(EPI)·당뇨·암 위험을 함께 봅니다.

외래에서 시점별로 확인



주기만 기다리지 말고 증상 변화가 생기면 즉시 평가합니다.

! 암을 의심하는 변화

임상 변화	영상·검사 변화
통증 변화·급격한 악화 / 설명되지 않는 체중감소	황달·담도 확장·ALP/bilirubin 상승
새 당뇨·빠른 혈당 악화	국소 췌관 협착 + 상류부 확장 / 십이지장 결절성 점막 등 영상 이상

위험도와 검사 해석

강의 제시	외래 적용
췌장암 발생률 1.4–2.7%; 진단 10년 후 1.8%, 20년 후 4%	CA19-9는 만성췌장염에서도 상승해 선별검사에 유용하지 않음. 작은 종양은 CT로도 어려워 기준 영상 비교.
췌장외 악성종양 3.9–12.5%; 상기도암 증가	추가적인 강한 위험인자가 있으면 주기적 영상 고려. 유전성 췌장염은 MRI·EUS 교대 평가.

치료의 중심은 증상 + 췌관 폐쇄

무증상 췌석·협착은 신중히, 통증과 폐쇄가 함께 있으면 감압을 고려합니다. 반복 시술 전 치료 목표를 재확인합니다.

광교바른내과 · 의료진 진료 참고
아산 28회 연수강좌 — 만성췌장염: 진단의 핵심과 치료의 실제(오동욱)
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

만성췌장염 외래 추적: 통증·영양·혈당·암 위험 신호

상세 확인 · 질환별 적용과 안전성

EPI를 의심할 단서와 영양

항목	확인 내용
증상	지방변·부피가 큰 변·악취 / 복부팽만·체중감소 / 통증 때문에 식사 회피.
결핍·뼈	지용성 비타민 결핍, 골감소·골다공증. 강의: 외분비기능 ≥90% 파괴 시 EPI 발생, 골다공증 이환율 약 34%.
영양 관리	비타민 D·칼슘 공급, 골밀도 검사, 영양상담·식사량 회복.

PERT: 식사와 함께 나누어 복용

항목	강의 제시 내용
시작	Lipase 40,000–50,000 U/meal. 간식은 절반 용량.
복용법	식사 시작–중간에 나누어 복용. 식사가 길어지면 분할.
반응 부족	순응도 확인 → 증량, PPI 추가 고려. 식후 한 번 복용·용량 부족·위산 불활성화·SIBO/celiac disease 등 다른 원인을 점검.
제형 예시	Creon 10,000/25,000/35,000 U, Norzyme 10,000/25,000/40,000 U. Lipase 함량을 기준으로 증상에 맞춰 선택.

췌장성 당뇨(T3cDM)

01 인슐린뿐 아니라 글루카곤도 감소: 저혈당 위험이 높고 EPI·영양불량이 함께 오기 쉽습니다.

02 HbA1c와 저혈당 병력을 함께 확인하고, 식사량·PERT·영양상태와 같이 조절합니다.

03 새 당뇨는 암 위험 신호이기도 합니다. 50세 이후 새 당뇨 + 체중감소·빠른 혈당 악화·황달·췌관확장 시 pancreas-protocol CT를 고려합니다.

연자 Q&A 의견

모두 처음부터 인슐린을 쓸 필요는 없지만 인슐린 결핍 진행으로 비교적 일찍 필요할 수 있습니다. 확실한 췌장염 병력이 있으면 DPP-4 억제제를 우선 선택하지 않는 것이 좋다는 답변입니다. C-peptide·CA19-9·amylase/lipase는 췌장암 선별에 적절하지 않습니다.

광교바른내과 · 의료진 진료 참고
아산 28회 연수강좌 — 만성췌장염: 진단의 핵심과 치료의 실제(오동욱)
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/asan28-chronic-pancreatitis-followup/